

migrétil®

A person is sitting on a couch, looking at a smartphone. Their head is replaced by a series of seven emojis that represent different symptoms of a headache: a crying face with a blue tear, a face with a musical note, a face with a wide-open mouth and large eyes, a face with a cloud and confetti coming out of the top, a face with spiral eyes, a green face with a frown, and a face with green vomit coming out of the mouth.

PORQUE A ENXAQUECA É MAIS QUE UMA DOR DE CABEÇA

Abril de 2024

Bial

migrétil®

ENXAQUECA



A enxaqueca é um tipo de cefaleia idiopática, benigna, recorrente, que se manifesta por crises que normalmente duram entre

4 E 72 HORAS.



A enxaqueca é uma **CEFALEIA DE ORIGEM NEUROVASCULAR FREQUENTE.**

É multifactorial, incapacitante, recorrente e hereditária.

**DOR INTENSA,
PULSÁTIL E
LATEJANTE**

**DURAÇÃO
ENTRE 4 A 72H**

Charles A. Migraine. *N Engl J Med.* 10 Ago 2017; 377(6): 553-561

DIAGNÓSTICO¹

01

Sem aura

02

Com aura

UM DOENTE PODE TER
AMBOS OS TIPOS DE
ENXAQUECA

Não existem testes de
diagnóstico para nenhuma
das cefaleias primárias

DIAGNÓSTICO DA ENXAQUECA³⁻⁶

Pelo menos 5 crises
de cefaleia que são:

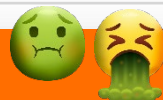


DURAÇÃO ENTRE
4 A 72 HORAS

- ▶ Unilaterais (apenas um lado da cabeça)
- ▶ Qualidade pulsante
- ▶ Dor moderada a grave
- 🌀 Sintomas agravados pela actividade física



PELO MENOS
DOIS DESTES
SINTOMAS



NÁUSEAS OU
VÔMITOS

SENSIBILIDADE/
INTOLERÂNCIA A:



Luz (fotofobia)



Ruído (fonofobia)

- ▶ Cheiros fortes



PELO MENOS
UM DESTES
SINTOMAS

COM OU
SEM AURA

1- Comité de Classificação das Cefaleias da International Headache Society (IHS). *The International Classification of Headache Disorders*, 3ª edição (versão beta). *Cephalalgia*. Jul 2013; 33(9): 629-808.

Adaptado de Comité de Classificação das Cefaleias da International Headache Society (IHS). *The International Classification of Headache Disorders*, 3ª edição. *Cephalalgia*. 2018 Jan; 38(1): 1-211.

FACTORES DESENCADEANTES

A enxaqueca pode ser desencadeada ou amplificada por diversos estímulos, que não são os mesmos para cada pessoa e podem nem sempre ser os mesmos em crises diferentes na mesma pessoa.



ALTERAÇÕES NOS PADRÕES DO SONO

Falta ou excesso de sono



ALIMENTOS

Jejum prolongado ou omissão de refeições, desidratação, consumo de álcool e alguns alimentos (por exemplo, queijo, chocolate, citrinos...)



FLUTUAÇÕES HORMONAIS

Menstruação ou perimenopausa



CAUSAS FÍSICAS

Exercício intenso, fadiga



CAUSAS PSICOLÓGICAS

Stress (ou relaxamento após o stress), ansiedade, depressão



ESTÍMULOS SENSORIAIS

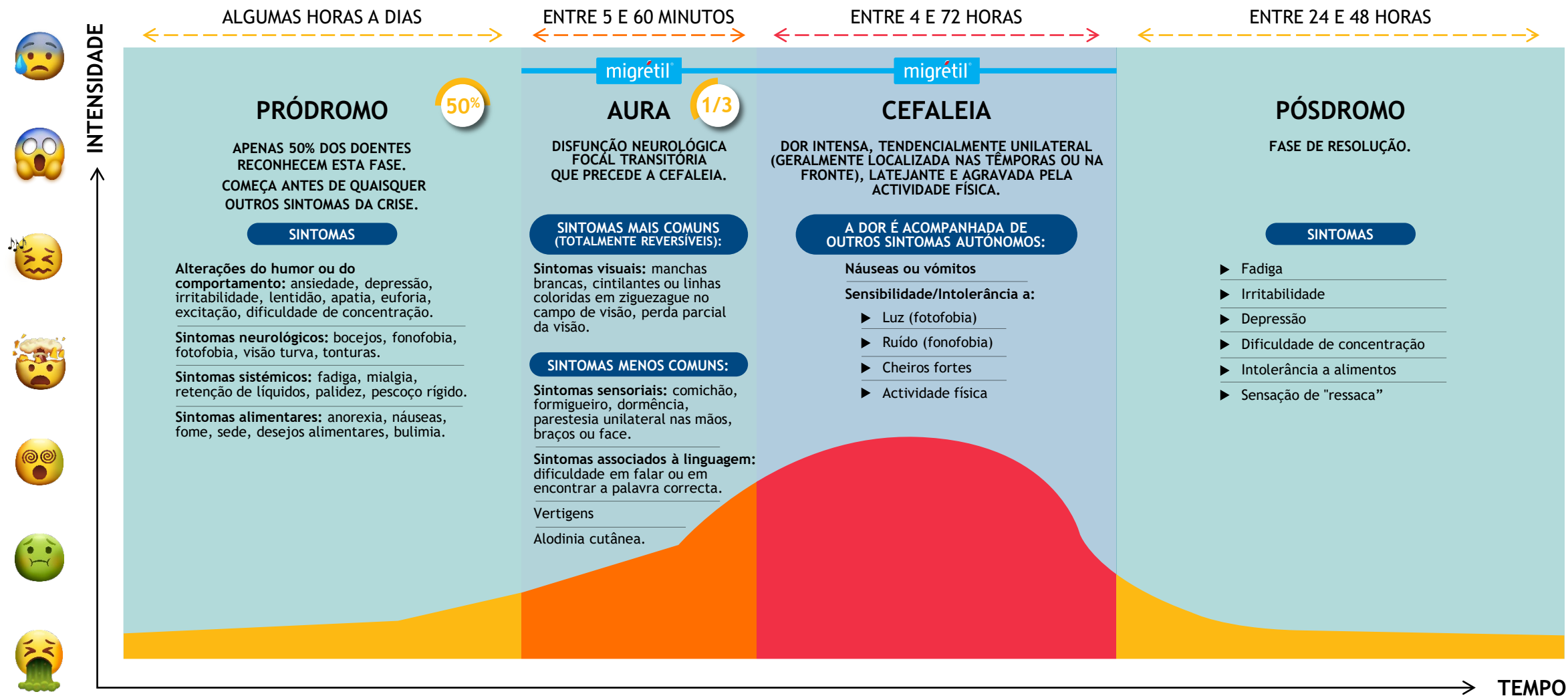
Luzes intensas ou cintilantes, ruído e cheiros fortes



ALTERAÇÕES AMBIENTAIS

Pressão, temperatura, fumo/poluição

FASES DA ENXAQUECA



* Nem todos os doentes passam por estas quatro fases, e estas podem variar consoante a crise. Além disso, as fases podem sobrepor-se.¹¹
Adaptado de MigraPortugal (disponível em: <https://migraportugal.pt/sobre-cefaleias/enxaqueca/>)

TRATAMENTO

Não-farmacológico.

Farmacológico.

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

Os medicamentos para uso em crises de enxaqueca podem ser divididos em:

Terapia sintomática

- ✓ AINE (naproxeno, ibuprofeno): reduzem a gravidade e a duração de uma crise de enxaqueca
- ✓ Analgésicos: Paracetamol (acetaminofeno)
- ✓ Antagonistas da dopamina (a absorção de medicamentos é reduzida durante a enxaqueca devido à motilidade gástrica reduzida)

Terapia específica

- ✓ Agonistas dos receptores da serotonina 5-HT₁ (Ergotamina e Triptanos)
(Os doentes tratados com ergotamina têm uma menor recorrência de cefaleias que os doentes tratados com triptanos, embora pareça existir uma maior incidência de náuseas)
- ✓ Associações de vários princípios activos (p.ex. Migrétil)

EFICÁCIA ESTABELECIDADA

PROVAVELMENTE EFICAZ

Específico para a enxaqueca

Triptanos

Ergotamina

Derivados da ergotamina

Outras formas de di-hidroergotamina

Gepantos

Lasmiditan

Não específicos para a enxaqueca

AINE: aspirina, celecoxib solução oral, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno

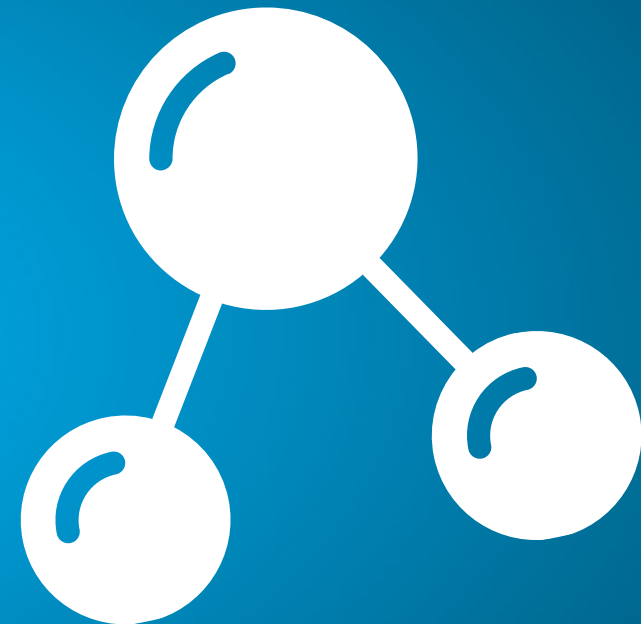
AINE: flurbiprofeno, cetoprofeno, ceterolac IV e IM

Analgésicos combinados: acetaminofeno + aspirina + cafeína

Magnésio IV

Compostos-contendo isometepteno

Antieméticos: clorpromazina, droperidol, metoclopramida, proclorperazina, prometazina



Adaptado de Ailani J, Burch RC, Robbins MS; Board of Directors of the American Headache Society. The American Headache Society Consensus Statement: Update on integrating new migraine treatments into clinical practice. *Headache*. Jul 2021; 61(7): 1021-1039

MIGRÉTIL



Bial

PARACETAMOL
400 mg

CAFEÍNA
100 mg

**TARTARATO DE
ERGOTAMINA**
1 mg

**ALCALOIDES DE
BELADONA**
0,1 mg

RCM de MIGRÉTIL

migrétil®

MIGRÉTIL



Bial

PARACETAMOL 400mg



- Efeito analgésico e antipirético (por um mecanismo não totalmente compreendido).
- Efeito analgésico
 - Pode actuar inibindo a síntese de prostaglandinas no SNC
 - Bloqueia periféricamente a génese do impulso da dor (por inibição das prostaglandinas e DE outras substâncias).
- É rápida e quase completamente absorvido no trato GI (Cmax obtida em 10-60 minutos).
- Excreção por via urinária.

MIGRÉTIL



Bial

CAFEÍNA 100mg



Mecanismos de acção:

- Potencia a acção da ergotamina, aumentando a sua absorção intestinal.
- Pode contribuir para a vasoconstrição cerebral e, consequentemente, para a redução do fluxo sanguíneo e da tensão local de oxigénio.
- A cafeína não exerce qualquer efeito analgésico intrínseco, contudo, as preparações que contêm cafeína têm sido descritas como tendo um efeito analgésico mais rápido e mais potente.
- É rápida e quase completamente absorvida no trato GI (Cmax obtida em 50-75 minutos).

MIGRÉTIL



Bial

TARTARATO DE ERGOTAMINA 1mg



Mecanismos de acção:

- Não completamente compreendidos, mas pensa-se que afecte a vasoconstrição das artérias carótidas externas, com diminuição concomitante da amplitude do pulso.
- Tem um efeito sobre as catecolaminas e a serotonina.
- Apresenta uma absorção gastrointestinal variável. Normalmente, a absorção é maior na primeira hora após a administração oral e em conjugação com cafeína.
- Tempo até à Cmax: 1h (com cafeína).
- Excreção fecal (biliar).

MIGRÉTIL



Bial

ALCALOIDES DE BELADONA 0,1 mg



- Os alcalóides de beladona exercem um efeito antiemético benéfico, contribuindo para o alívio sintomático da crise.
 - Estase gástrica, náuseas e vômitos são sintomas e sinais presentes na maioria dos casos de enxaqueca.
- Bem absorvidos no trato GI.
- Excreção urinária e fecal.

MIGRÉTIL



Bial

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Tratamento de crises de enxaqueca.

Não está indicado como tratamento preventivo.

DOSAGEM

ADULTOS



Dois comprimidos, de uma vez só, durante a aura ou no início da cefaleia.

Se necessário,
1 comprimido adicional.

Se necessário,
1 comprimido adicional.

ADOLESCENTES



Um comprimido durante a aura ou no início da cefaleia.

Se necessário,
1 comprimido adicional.

Não está indicado
em crianças
menores que 12
anos.



- Os comprimidos devem ser ingeridos o mais precocemente possível, logo após os primeiros sintomas da crise de enxaqueca.
- Não tomar mais de 6 comprimidos por dia ou mais de 10 a 12 comprimidos por semana.
- Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros, com a ajuda de um pouco de água.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Hipersensibilidade a qualquer dos componentes
- Gravidez e aleitamento (pode causar abortos e malformações fetais, pelo que não deve ser utilizado durante a gravidez)
- Alcoolismo activo
- Insuficiência hepática significativa
- Angioplastia ou cirurgia vascular recentes ou previstas
- Doença vascular periférica oclusiva
- Hipertensão não controlada
- Doença coronária

EFEITOS INDESEJÁVEIS

ÀS DOSES RECOMENDADAS, MIGRÉTIL É GERALMENTE BEM TOLERADO.

No entanto, podem ocorrer alguns efeitos indesejáveis:

- Reacções de hipersensibilidade cutânea
- Sinais de irritação gástrica, náuseas e diarreia
- Insónia, irritabilidade, vertigens
- Mialgia, parestesia e diminuição da força dos membros inferiores
- Efeitos de vasoconstrição (extremidades frias, dormentes e dolorosas, com ou sem parestesia)

PRECAUÇÕES ESPECIAIS

- O risco de complicações aumenta nos casos de infecção grave ou insuficiência renal significativa, bem como nos idosos.
- Em doentes com perturbações da ansiedade, a cafeína pode exacerbar os seus sintomas. Deve evitar-se o uso concomitante de bebidas contendo cafeína.
- Os doentes com hipertrofia da próstata, retenção urinária, doença gastrointestinal oclusiva ou glaucoma podem sofrer de eventos indesejáveis resultantes da acção dos alcalóides da beladona, apesar de as doses utilizadas no medicamento serem baixas.

MIGRÉTIL



Bial



MUITO OBRIGADO!

migrétil®